

Toxicomanías

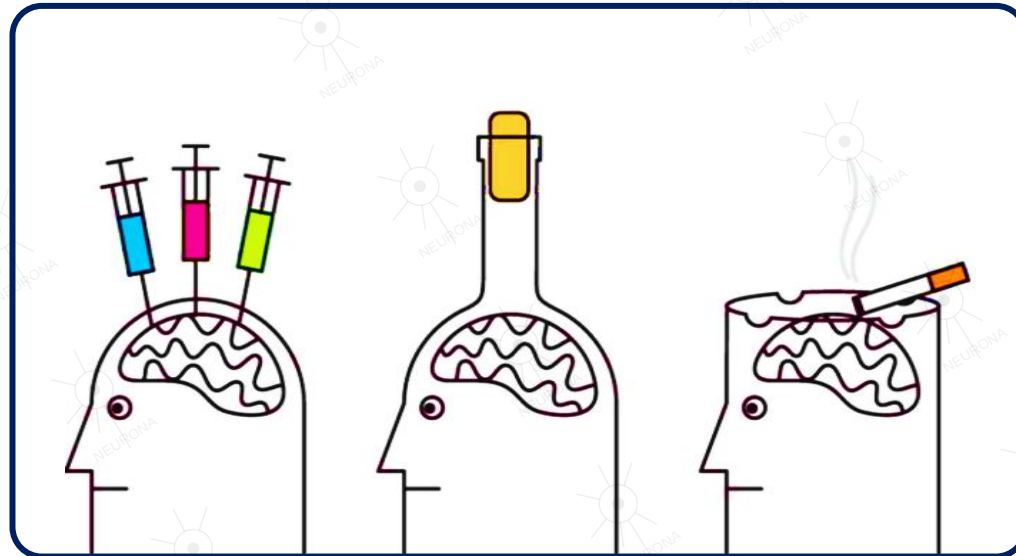
Dr. Andréé Salvatierra

Abuso de sustancias



Se conoce como abuso de sustancias a la ingestión en cantidades y circunstancias que se desvían de las pautas sociales o médicas aceptadas en una cultura determinada.

Dependencia



Ocurre cuando aparecen un conjunto de signos y síntomas, donde hay **poco o ningún control en el consumo**, y este **se continua a pesar de** aparecer **efectos tóxicos**, en parte para paliar los efectos de un síndrome de abstinencia

**Existen numerosas variables: debidas a la sustancia, capacidad de generar tolerancia, condicionantes psicológicas, sociales y culturales.*

Opiáceos



1803 se aisló de los componentes del opio la morfina, a partir de la cual se produjeron numerosos casos de dependencia de este fármaco, debido a que coincidió con el invento de la jeringuilla hipodérmica.

En nuestro tiempo la heroína, uno de sus derivados químicos, posee gran capacidad de dependencia, que con el tiempo crea tolerancia, de forma que se requieren dosis cada vez más altas para conseguir sus efectos.

«Adormidera»
papaver somniferum



Puede resultar ligeramente venenosa si es ingerida por animales herbívoros, pero cocinada o infusionada pierde su toxicidad.

Los alcaloides contenidos en la flor tienen propiedades sedantes; es utilizada por algunas personas para realizar infusiones, que se recomiendan en casos de insomnio y ansiedad. Otras de sus propiedades son sus efectos expectorantes y su uso para combatir la tos.

Efectos de la heroína

- ☐ Analgesia.
- ☐ Miosis (contracción pupilar).
- ☐ Euforia, con sensación de gran bienestar.
- ☐ Puede provocar confusión.
- ☐ Depresión respiratoria (se potencia con depresores del SNC: alcohol/ BZD).
- ☐ Estimula el centro del vómito.
- ☐ Produce retención urinaria y reduce los movimientos intestinales.
- ☐ Puede provocar urticaria en la piel.
- ☐ Puede inducir el parto.
- ☐ Altamente adictiva.

Ante una sobredosis, el paciente presentará como complicación importante depresión respiratoria que puede conllevar su muerte.

Se han sintetizado por ello antagonistas de receptores de morfina, **Naloxona y Naltrexona**, que revierten los efectos de la sobredosis.

Naltrexona: $t_{1/2}$ 10h, dosis oral 100 mg/día es capaz de bloquear los efectos de la heroína.

Naloxona: (I.V/I.M): 0,01 mg/kg o bien 0,4 mg/kg - dosis única

Metadona

Sustancia sintética derivada del opio, controlada por las autoridades sanitarias (distribución restringida). Es un analgésico potente similar a la morfina, pero sin un efecto sedante tan fuerte.

Dosis: Inicialmente se suministra dosis diarias equivalentes al consumo del paciente, con el fin de retirar paulatinamente la sustancia e introducir dosis reducidas de metadona vía oral.

(i) 10-30 mg/día, según respuesta aumentar hasta 40-60 mg/día en 1 a 2 sem. Mantenimiento: 60-100 mg/día, alcanzándose con incrementos sucesivos semanales de 10 mg/día.

Cannabis



Cannabis
Sativa

Los derivados del cannabis se obtienen a través de la planta del cáñamo, que tiene una sustancia llamada Tetra-hidro cannabitol (THC).

De ella se pueden obtener 2 formas esenciales para su consumo como estupefaciente (psicótropeo con alto potencial de producir adicción)

- ☐ *Marihuana: Una mezcla de flores, hojas y tallos*
- ☐ *Hachís : La resina de la planta.*



Sus efectos dependen de la vía de absorción, pero curiosamente varían en función del entorno en el que se consume y del estado afectivo predominante.

Efecto enteógeno: favorecen las actividades místicas

Efectos

- ☐ Euforia, relajación, sensación de enlentecimiento del transcurrir del tiempo, autoconfianza, ilusiones sensoriales, alucinaciones, incremento del deseo sexual, sensación de flotar. Puede desencadenar crisis de pánico o cuadros psicóticos.
- ☐ Vasodilatación, especialmente conjuntiva provocando el efecto de ojos rojos
- ☐ Para un observador externo, es una conducta pasiva con hilaridad
- ☐ El cuadro de dependencia es progresivo, pasando desapercibido por el propio paciente.

Anfetaminas



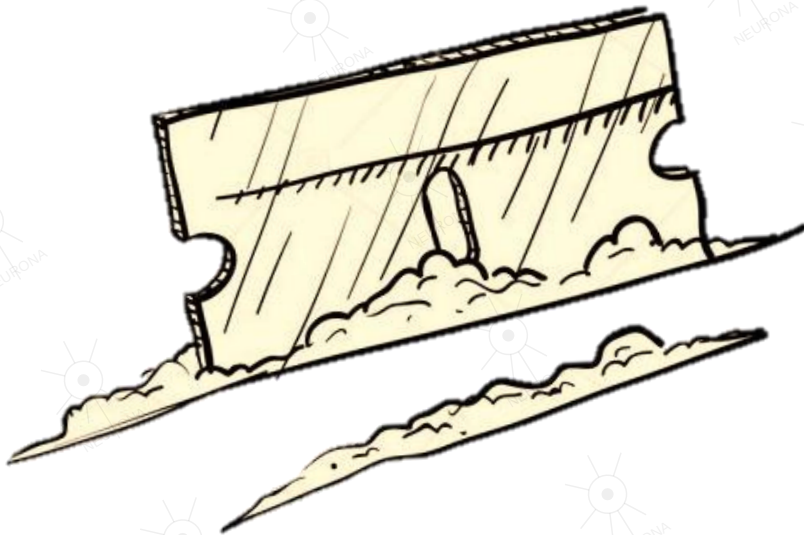
- ☐ Grupo de sustancia estimulante del SNC, muy usadas como drogas recreativas
- ☐ Su mecanismo de acción promueve la liberación de NA, DA y 5-HT

Efectos

- ☐ Aumento de concentración.
- ☐ Disminución de la necesidad de sueño y la fatiga.
- ☐ Disminución del apetito
- ☐ Euforia, sensación de poder y autoconfianza
- ☐ Incremento de conductas agresivas y cuadros psicóticos.
- ☐ Taquicardia, hipertermia.

Como efecto adverso ante exceso de dosis destaca el “golpe de calor”, con taquicardia, posibles arritmias y sobretudo una creciente hipertermia y muerte del paciente.

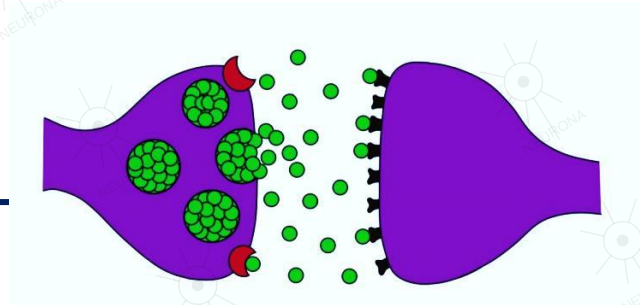
Cocaína



Usado como analgésico y vigorizante, ampliamente usada en las culturas andinas, reduce la sensación de fatiga y la sensación de hambre,

Siglo XIX, llega a Europa y se sintetiza en forma de polvo blanco (Hidrato de cloral); pronto se extiende a otras formas de consumo: fumado, esnifado, intravenoso (objetivo asegurar un paso rápido al SNC)

La cocaína es un estimulante del S.N.C. con gran capacidad de recompensa (refuerzo positivo), siendo un potente adictógeno con capacidad de generar dependencia.



Su mecanismo de acción es a través de la **inhibición de la recaptación** de catecolaminas(NA, 5-HT, sobretodo **DA**).

Su potencialidad adictiva se relaciona con la transmisión dopaminérgica a través de los receptores D1 y D2.

****América Central y en los Andes, los nativos consumen hojas de coca, pero su masticación da lugar a un paso enlentecido desde estómago a la sangre, su entrada y acción cerebral es más paulatina, menos intensa y adictiva**

Neuroanatomía implicada

Núcleo accumbens

Centro modulador de conductas en las que intervienen la **recompensa** y el **esfuerzo**

Amígdala

Centro modulador de **conductas afectivas** inmediatas

Corteza pre-frontal

Centro integrador de la capacidad de **inhibir** los **impulsos** y el cálculo del **riesgo**

Hipocampo

Memoria/ hábitos

Formas de consumo



Esnifada

Se absorbe en el flujo sanguíneo a través de las membranas mucosas de la nariz; puede causar alteraciones y perforación de tabique nasal por el efecto vasoconstrictor y anestésico.



Intravenosa

Se destruye el tejido cutáneo con rapidez y causa ulceración; > riesgo de padecer infecciones parenterales (hepatitis, VIH).



Fumada

Forma más rápida de introducir la droga en el cerebro.

Efectos

- ☐ Euforia e hipersexualidad (incluida eyaculación espontánea).
- ☐ Hiperactividad psicomotora
- ☐ Hiperactividad verbal e ideativa
- ☐ Hipertermia y convulsiones.
- ☐ Taquicardia, arritmias, isquemias (porque producen vasoconstricción).
- ☐ Midriasis (dilatación anormal de la pupila).
- ☐ Alucinaciones (táctiles).
- ☐ Aumento de la energía, ansiedad y agitación
- ☐ Disminución del apetito, fatiga y sueño
- ☐ Conducta estereotipada (bruxismo)

En conjunto con el etanol, se transforma en cocaetileno de mayor actividad farmacológica y tóxica a nivel cardíaco y hepático

Abstinencia

Leve

Letargia, debilidad, irritabilidad, dolores y molestias inespecíficas, trastornos del sueño, etc

Grave

Ideación suicida, ansiedad, insomnio severo, desesperanza. Se denomina «crash» y puede durar hasta 4 días.

«Craving» → Deseo irrefrenable de consumir una sustancia, se remite a las 72h tras el cese del consumo, sin necesariamente administrar fármacos.

Tratamiento farmacológico

- **BZD** : *Halazepan* → (i) 20 mg hasta 40 mg 3-4 veces al día
- **AD** : *Trazodona* → (i) 50mg hasta 400mg/día,
ISRS (sedativo) *paroxetina* → (i) 10mg, dosis ideal 40mg
- **Eutimizantes** : *Topiramato y lamotrigina*: (i) 25mg noche.
Incrementar 25mg/semanal en 2 dosis. Mantenimiento:100-300mg/día repartido en 3 dosis.
- **Gabapentina** : Antiepiléptico/(i) 400mg por la noche durante 3 días, después 400mg mañana y noche. Mant.: 400mg/3 veces al día.
- **A.A.** : *Risperidona, olanzapina* (dosis bajas)
contrarrestan propiedades gratificantes de la cocaína

MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina)

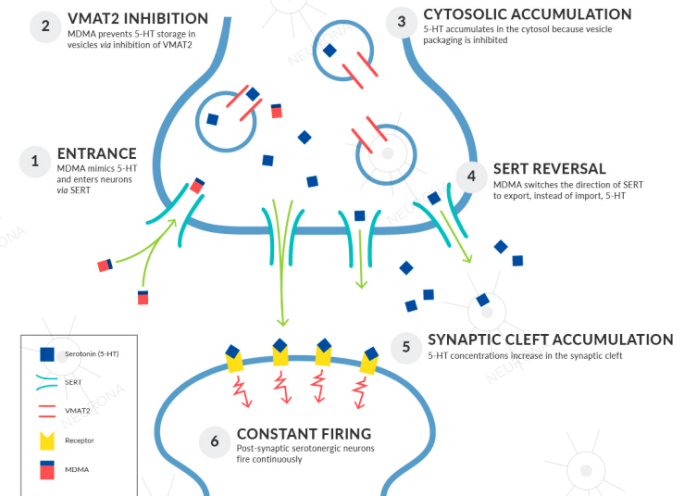
Farmacodinamia

Mecanismo de acción:

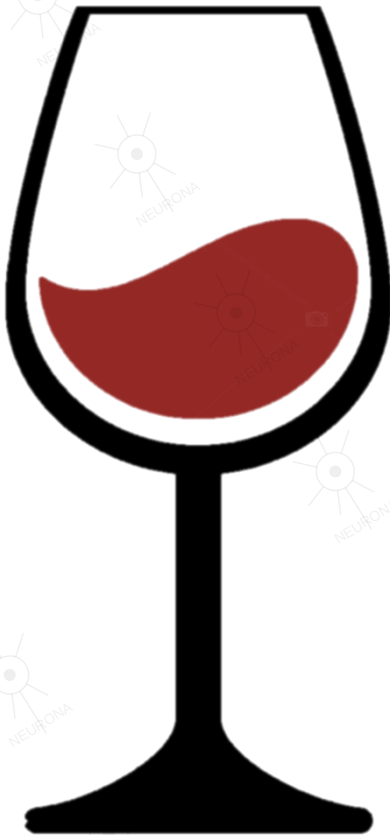
- Potente **liberador de serotonina (5-HT)**, además de dopamina (DA) y noradrenalina (NA).
- Inhibe la recaptura (SERT, DAT, NET) y provoca la **liberación vesicular de 5-HT** → aumento masivo de serotonina sináptica.
- También actúa sobre **receptores oxitocínicos y adrenérgicos**.

Efectos conductuales y fisiológicos:

- Euforia, empatía intensa, sensación de conexión emocional.
- Estimulación física moderada, aumento de la percepción sensorial.
- Hipertermia, sudoración y taquicardia.

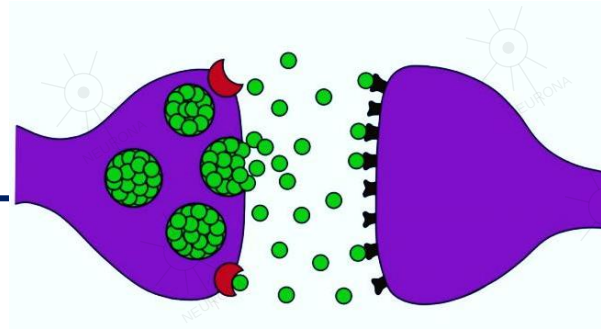


Alcohol



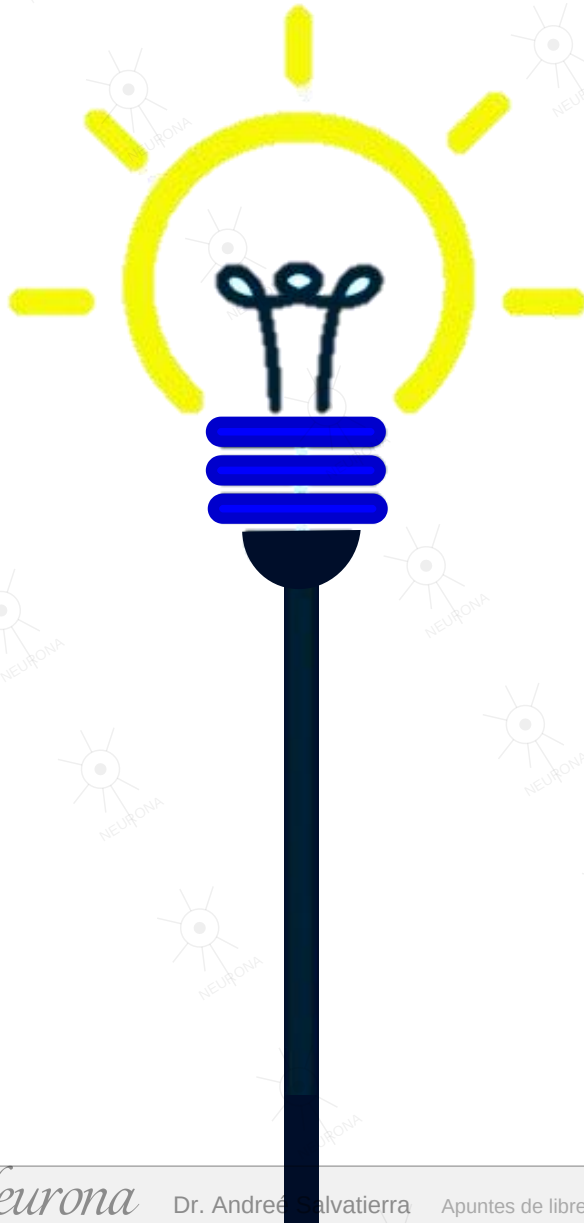
El consumo de alcohol con criterios de abuso o dependencia supone un importante problema de salud pública.

Suele ser de predominio masculino, con hasta una incidencia torno al 13% en casi todas las culturas y con consecuencias derivadas de su uso (mortalidad directa, accidentes, secuelas físicas, etc.)



La administración aguda de alcohol produce una facilitación de la **actividad inhibitoria** del **GABA**, que, sumada a una **reducción** de la actividad **excitatoria** del **glutamato**, los canales de calcio y NA. Así, se reduce la frecuencia de los impulsos eléctricos y deprime la actividad del SNC.

Por otro lado, puede llegar a **estimular** la liberación de **DA**, con lo cual se explicarían los mecanismos de estimulación/placer y efecto de recompensa que produce el alcohol. Su consumo crónico, **activa** el **sistema opiáceo** endógeno liberando beta-endorfinas



Cambios neuroadaptativos (compensatorios)

Cuando la exposición al alcohol es crónica:

El organismo se adapta disminuyendo Gaba (inhibidor) y aumentando Glutamato (excitador); para producir un aumento de la excitabilidad neuronal y contrarrestar efectos depresores del alcohol

Al suprimir el consumo:

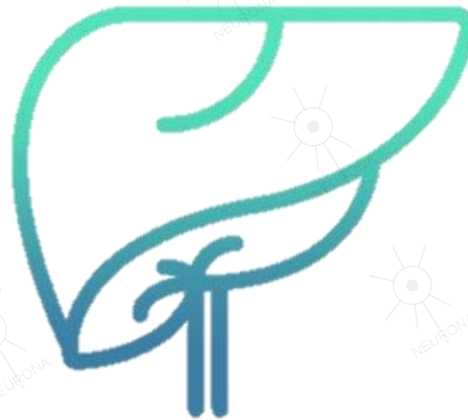
El efecto depresor desaparece, pero, las neuronas permanecen hiperexcitables y requerirán tiempo para readaptarse, periodo en el cual se desencadenan síntomas como: ansiedad, insomnio y craving.

Metabolización

- ❑ Se metaboliza en el **hígado** de forma preferente
- ❑ El alcohol en el hígado es transformado en Acetaldehído, y luego a acetato. Se elimina a una velocidad constante de 10 ml/hora.

90% → Metabolizado por el hígado

10% → Expulsado directamente en orina y pulmones



Efectos

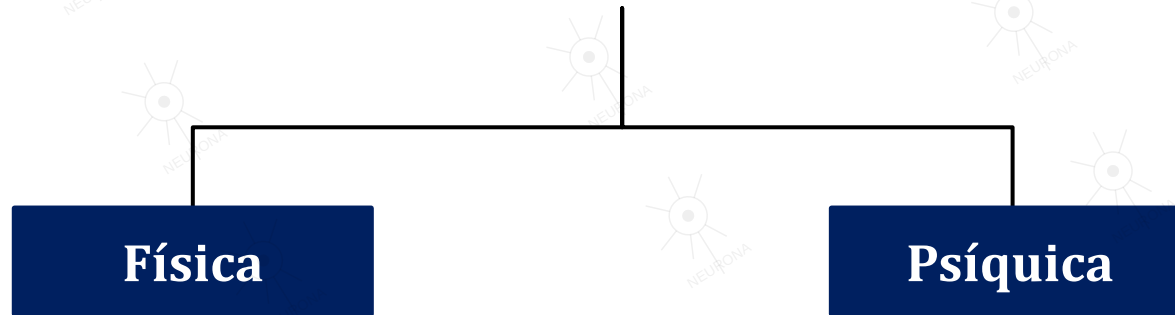
Existe una enorme variación idiosincrática de individuo a individuo

<i>gr alcohol / L sangre</i>	<i>Estado</i>
0 – 0.5	• Leve alegría
0.5 – 1	• Alegría, menor juicio y concentración, • Desinhibición social • Lentitud, torpeza, disminución del campo visual
1 – 1.5	• Inestabilidad emocional, confusiones • Descontrol, agresividad • Andar tambaleantes, visión doble
1.5 - 2	• Incoherencia, tristeza, rabia • > descontrol, mareo vómitos • Dificultad para hablar y caminar
2 - 3	• Escasa conciencia, apatía e inercia • Incontinencia de esfínteres, incapacidad de hablar y caminar
3 - 4	• Coma (estado profundo de inconsciencia)

Litros de sangre del cuerpo humano → 7% del peso corporal

Dependencia

Ocurre cuando aparecen un conjunto de signos y síntomas, donde hay **poco o ningún control en el consumo**, y este **se continua a pesar de** aparecer **efectos tóxicos**, en parte para paliar los efectos desagradables de un síndrome de abstinencia



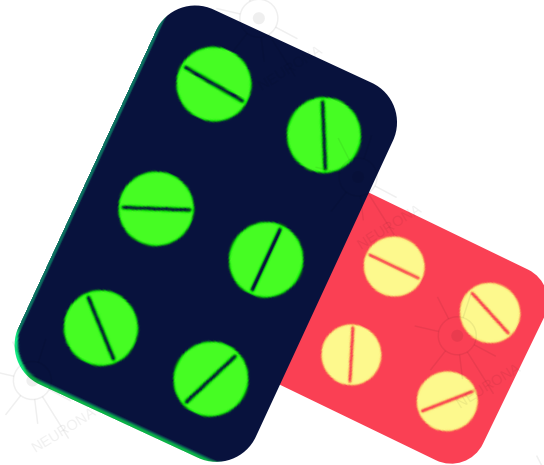
Tratamiento de la dependencia

Cuando se inicia un proceso de desintoxicación, lo importante es **evitar la aparición del síndrome de abstinencia.**

Resulta relativamente sencillo mediante dosis descendentes de BZD, dar ayuda psicológica es fundamental para lograr una verdadera deshabituación. Se puede utilizar un morfíco de t ½ larga, como la metadona para casos determinados y siempre bajo supervisión.

Dependencia física

Se manifiesta con la supresión brusca de la sustancia, comienza así un síndrome de abstinencia físico con **hiperactividad adrenérgica** que explica los síntomas: piloerección, taquicardia, sudoración, temblor, nerviosismo, dolor generalizado, malestar gastrointestinal y vómitos.



Metadona

(i) 10-30mg/día, según respuesta aumentar hasta 40-60 mg/día en 1 a 2 sem. Mantenimiento: 60-100 mg/día (incremento 10 mg/día cada semana)

Patologías

El uso en forma aguda supone una depresión del SNC comenzando por zonas inhibitoras (CPF), afectando al cerebelo y extendiendo sus efectos depresores en otras áreas

Neurológicas

Atrofia cerebral y cerebelosa, síndrome de W-Korsakoff

Gástricas

Irrita la mucosa provocando gastritis, debido a ello se generan vómitos en el sueño nocturno

Endocrinas

Al inhibir la producción de testosterona provoca impotencia y feminización

Hepáticas

Las células hepáticas van acumulando grasa y pronto se fibrosan y mueren (cirrosis hepática)

Teratogénicas

Síndrome de alcoholismo fetal

Síndrome de Wernicke-Korsakoff

Es formado por dos síndromes, aunque algunos científicos creen que son diferentes etapas de una misma enfermedad; es producida por el consumo continuado de alcohol, que lleva al organismo a una **deficiencia de vitamina B1** (tiamina).

La tiamina es un cofactor para varias enzimas que son importantes en el metabolismo energético. Debido a la función de tiamina en la utilización de energía cerebral, se ha propuesto que su deficiencia inicia la lesión de las neuronas.

S. Wernicke

Fase aguda

Caracterizada por confusión, anomalías de postura y marcha (ataxia) y movimientos anormales de ojos (nistagmo).

S. Korsakoff

Fase crónica

Tipo de demencia, se caracteriza por la pérdida de memoria(talamo) y fabulación compensatoria, alucinaciones

*La atención y el comportamiento social están relativamente conservados.
Los pacientes pueden ser capaces de mantener una conversación social adecuada*

Trastornos duales

Trastorno
Psiquiátrico

+

Adicción

Comorbilidad

Trastorno
Psiquiátrico A

+

Trastornos
Psiquiátrico B



Hipersensibilización

Es el **incremento de respuesta** de una célula a la acción de un ligando

- ☐ Incremento del acoplamiento entre el receptor.
- ☐ Aumento del nº de receptores por reducción de la degradación metabólica o incremento en el proceso de síntesis de nuevas proteínas receptoras.
- ☐ Incremento de la afinidad (fármaco – receptor)



Desensibilización

Perdida de respuesta de una célula a la acción de un ligando, puede conllevar:

- ☐ Inhibición del acoplamiento entre el receptor.
- ☐ Reducción del nº de receptores por alza de la degradación metabólica o reducción en la síntesis de nuevas proteínas receptoras.
- ☐ Disminución en la afinidad (fármaco – receptor)



Neuroadaptación

Conjunto de cambios neurales adaptativos que subyacen tanto a la tolerancia como a la sintomatología.

Producidas por el consumo de sustancias adictivas en forma continuada, la cual justifica la tolerancia.

Embriaguez patológica

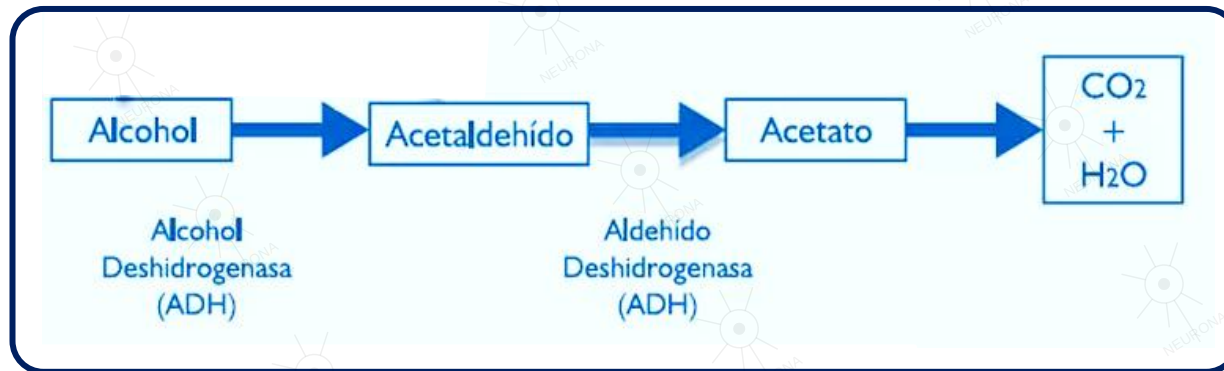


Alteración de la conducta que se desarrolla inmediatamente después de consumir una pequeña cantidad de alcohol; pudiendo desencadenar confusión, desorientación, ilusiones y alucinaciones visuales.

El episodio dura unas horas y va seguido de amnesia posterior; aparece con frecuencia en sujetos con lesiones cerebrales.

Interdictores

Disulfiram y Cianamida (llamados interdictores). Se administran una vez al día, y durante 48 h el paciente no puede **ingerir alcohol**; si lo hace **notará un malestar significativo**.



Estos fármacos **interfieren** en el **metabolismo del alcohol**, **inhiben** la acción de la **aldehído deshidrogenasa** y provocan un incremento de los niveles plasmáticos de acetaldehído responsable de síntomas como: taquicardia, hipotensión, rubefacción, cefalea...

Tratamiento farmacológico

☐ **Acomprasato**

:Actividad como *agonista GABA* y como *inhibidor de Glutamato NMDA*; (comprimidos de 333mg) dosis **>60kg** = 2 comprimidos 3 veces al día (2 mañana, 2 mediodía, 2 noches); **<60kg** = 4 comprimidos en tres tomas diarias (2 mañana, 1 mediodía y 1 noche).

☐ **Naltrexona**

:Efecto específico sobre el deseo de beber; contraindicado en hepatopatías; dosis habitual de 50mg/día hasta 100mg/día

☐ **Nalmefeno**

:Antagonista opiáceo, debe tomarse un comprimido(18mg/día) preferiblemente 1-2h antes del momento del consumo de alcohol; estudios hasta >50 mg/día

☐ **Buspirona**

:Agonista 5-HT_{1A} con perfil ansiolítico; dosis 20-60mg/día

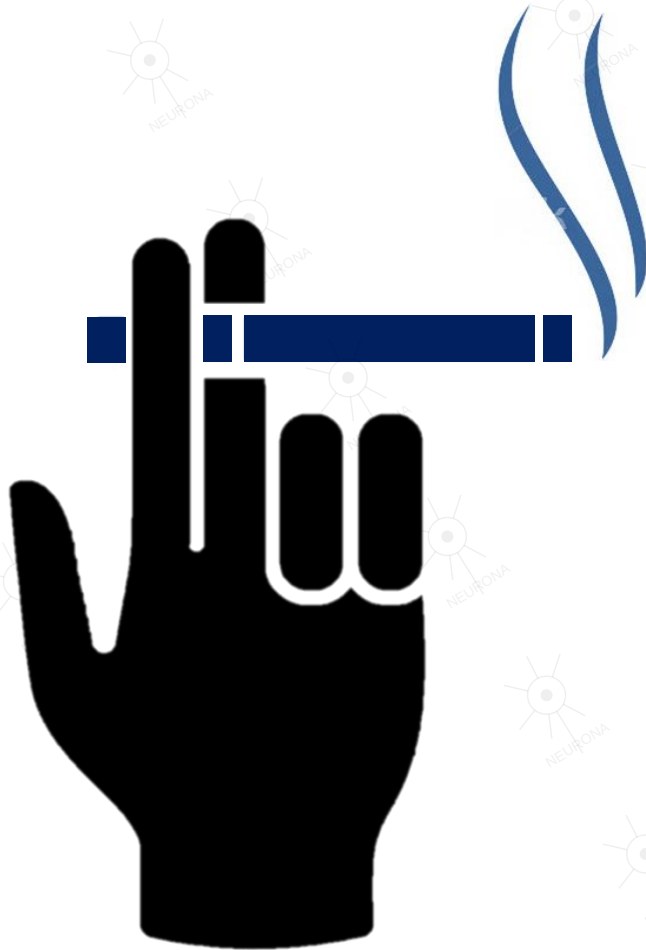
☐ **Ondansetron**

:Fármaco serotoninérgico, actúa a nivel del receptor 5-HT₃ y que se usa como potente antiemético. (5-HT₃) se ha relacionado con las conductas adictivas; dosis 8mg

☐ **ISRS**

:Citalopram, sertralina

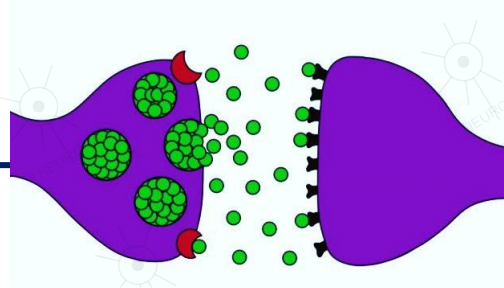
Nicotina



Alcaloide que se extrae de la planta del tabaco; actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos del cuerpo.

En los cigarrillos, se absorbe de forma rápida e intensa el pulmón, al llegar al SNC refuerza el consumo, al provocar un incremento en la atención, memoria y reducir la irritabilidad.

Los fumadores relatan que les ayuda a “despejarse”. En realidad, esto es una reversión de los efectos de la abstinencia, pues provoca una fuerte dependencia psíquica y algo menos física.



Actúa sobre receptores **ACh** situados en el área tegmental ventral del mesencéfalo; siendo capaz de **incrementar en el número y función de los receptores nicotínicos** (alfa4 y beta2), provocando dependencia y llevando a la búsqueda incontrolada e insana de nicotina a través del consumo continuado de cigarrillos.

Por otro lado, la estimulación de estos receptores conduce a un **incremento** de la liberación de **DA** en el núcleo accumbens, que estaría relacionado con los circuitos de **recompensa**.

Nicotina

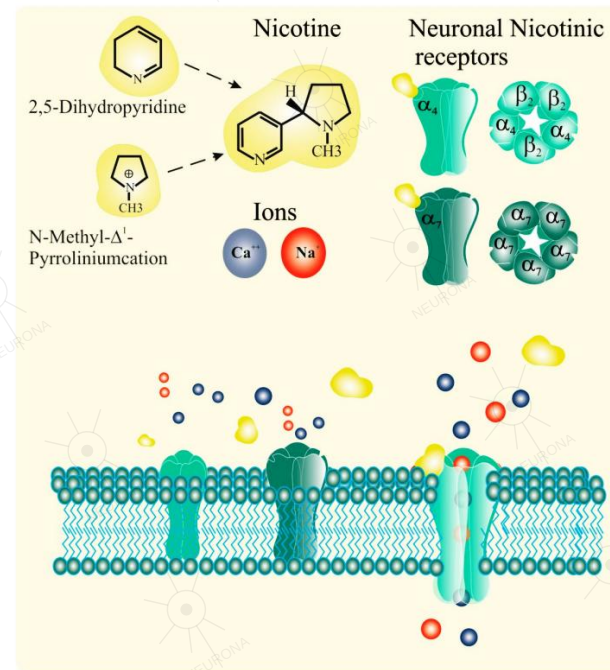
Farmacodinamia

Mecanismo de acción:

- Agonista de los **receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR)**, presentes en el sistema nervioso central y periférico.
- Su activación en el **área tegmental ventral (VTA)** estimula la liberación de **dopamina en el núcleo accumbens**, generando reforzamiento.
- También estimula liberación de **glutamato, noradrenalina, serotonina y GABA**.

Efectos conductuales y fisiológicos:

- Aumento del estado de alerta, reducción del apetito, ligera euforia.
- Aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial.



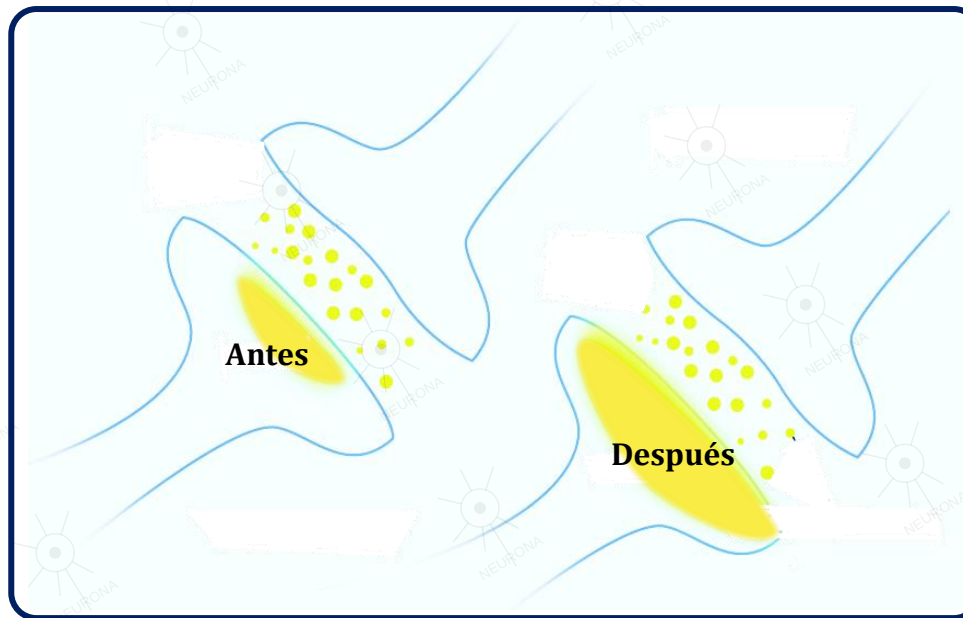
Síndrome de abstinencia

Aparece a las 2h de haber dejado de fumar, con intensidad máxima hacia las 24-48h, descendiendo de forma progresiva durante las siguientes semanas.

Los síntomas más habituales son:

- ☐ Disforia e irritabilidad.
- ☐ Problemas de sueño.
- ☐ > apetito (*nicotina per se tiene efecto anorexígeno*)
- ☐ Cefalea.
- ☐ Estreñimiento.
- ☐ < concentración
- ☐ Alteraciones en la memoria inmediata
- ☐ Alteración del sistema inmunitario
- ☐ Problemas cardiacos (*liberación ácidos grasos en torrente sang.*)





Cuando un fumador después de un corto periodo de abstinencia da una calada a un cigarrillo, inhala una cantidad de nicotina que ocupa el 50% de los receptores nicotínicos presentes en sus neuronas.

Esto supone que **los fumadores tienen** muchos de sus **receptores nicotínicos cubiertos**, después del consumo de los primeros cigarrillos del día. No obstante, **a pesar de esto, continúan fumando**.

La nicotina, aún y cuando muchos receptores nicotínicos están ocupados, **conduce al incremento de receptores en las neuronas del fumador**, produciendo: dependencia, tolerancia y abstinencia

Tratamiento

Existen dos tipos de fármacos:

- ☐ 1º línea: la Terapia sustitutiva con nicotina (TSN), bupropion y vareniclina
- ☐ 2º línea: clonidina y nortriptilina^{1- 8}.

Como en todo trastorno psíquico, el tratamiento debe incluir una combinación de tratamiento farmacológico, y apoyo psicológico

Terapia sustitutiva con nicotina

Se define como la administración de nicotina por una vía diferente a la del consumo del cigarrillo; en cantidad **suficiente para disminuir los síntomas** del s. abstinencia, pero **insuficiente para crear dependencia**.

Administración: oral (chicles de nicotina), inhalador bucal, caramelos, tabletas sublinguales, transdérmicos (parches) o spray nasal. En cualquiera caso, la concentración plasmática de nicotina **nunca alcanza niveles que se obtienen cuando se fuma un cigarrillo**.



Chicles de nicotina

Contienen 2-4mg de nicotina, al usarlo los niveles de nicotinemia alcanzan 5ng/ml (cifra mín. necesaria para estimular receptores nicotínicos y disminuir síntomas de abstinencia)

No utilizar en combinación con soda, café y cerveza, hasta al menos 15min después (disminuyen sus niveles de concentración)

Duración del tratamiento: 8 y 12 semanas, hasta 12 meses con reducciones de dosis a partir del 2 mes.



Comprimido de nicotina

Contiene 1 ó 2mg de nicotina, absorción similar a los chicles de 2 ó 4 mg.

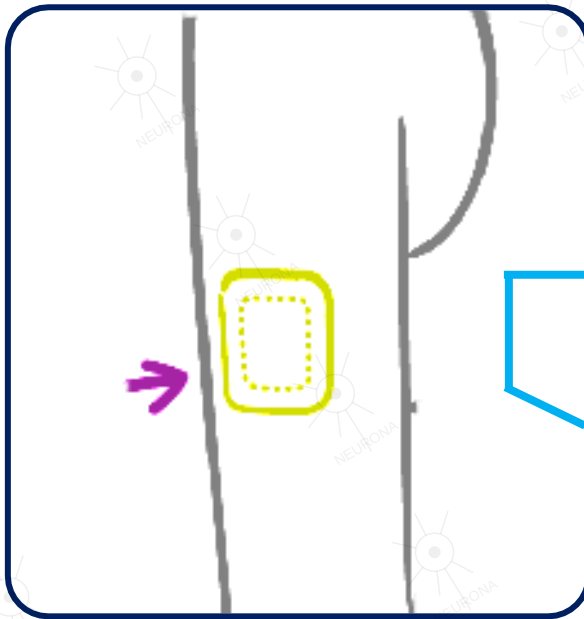
Dosis: 1-2 comprimidos c/ hora, durante 6 a 8 semanas, reducir progresivamente hasta 12 semanas de tratamiento.

Uso sencillo y escasez de efectos adversos



**Recomendado para fumadores menos dependientes*

Parche de nicotina



Dos tipos: los que liberan nicotina durante 24h (usados todo el día) y 16h (mientras el sujeto esta despierto)

En fumadores con dependencia severa (>7 puntos en test de Fagerström) conviene utilizarlos en combinación con los chicles de nicotina.



Embarazo y lactancia

No se recomienda TSN, a menos que la madre sea incapaz de dejar de fumar.

Bupropión

No se conoce con exactitud su mecanismo de acción, se sabe que actúa a nivel del núcleo accumbens **inhibiendo** la **recaptación** de **DA**, logrando **reducir el craving**

Estudios evidencias su acción como **inhibidor** no competitivo de los receptores nicotínicos de **ACh**, lo cual **explica** su **eficacia** en el tratamiento de la **dependencia nicotínica**

El tratamiento se inicia de 7 a 15 días antes de abandonar definitivamente el consumo del tabaco. 1º semana sólo 1 comprimido de 150 mg/día, después incrementar a 2 comprimidos de 150 mg al día (tomar el 1ro al levantarse y 2do 8h después, hasta por 9 semanas)

Vareniclina

Actúa como **agonista parcial** (cumple **características agonistas y antagonistas**) de los receptores nicotínicos en el área tegmental ventral del mesencéfalo; **estimula receptores** nicotínicos siendo capaz de **controlar el craving y abstinencia**. Por otro lado, **bloquea** los efecto de **placenteros** de la nicotina. Así, facilita que las recaídas no se conviertan en fracasos, ya que **se ocupan los receptores pero sin que estos se acompañen de placer y recompensa**.

1º semana los pacientes podrán fumar, durante los 3 primeros días dosis de 0.5 mg/día, después a dosis de 0.5 mg/2 veces al día, hasta completar la 1º semana. Pasado este tiempo, el sujeto deberá abandonar el consumo de tabaco y comenzar dosis de 1 mg/2 veces al día hasta por 12 semanas de tratamiento.

Antagonistas GLU y agonistas GABA

(Topiramato, acamprosato, baclofeno, gabapentina, imidazenil)

Topiramato

Es capaz de controlar los cambios de humor y la intensidad que se caracteriza los 1ros días del consumo de sustancias; disminuye significativamente el craving, la frecuencia y dosis de consumo de diversas sustancias, con especial interés en pacientes con niveles altos de impulsividad; tiene un perfil de seguridad satisfactorio.

25 mg/día hasta 300 mg/día

Fármacos en dependencia

Ag. Opiáceos

Metadona*, buprenorfina
(1ª línea)

Ant. Opiáceos

Naloxona, naltrexona
(2ª línea)

AA

Clozapina, olanzapina, pirenzepina
Pueden bloquear los efectos comportamentales y refuerzo (+), complicaciones por tolerancia.

Triptanes

Sumatriptan*, motriptan, naratriptan, rizatriptan...
Empleados para migrañas agudas

ISRS

Fluoxetina, sertralina
Estudios experimentales

Ant. NA

Propanolol, clonidina, lofexidina

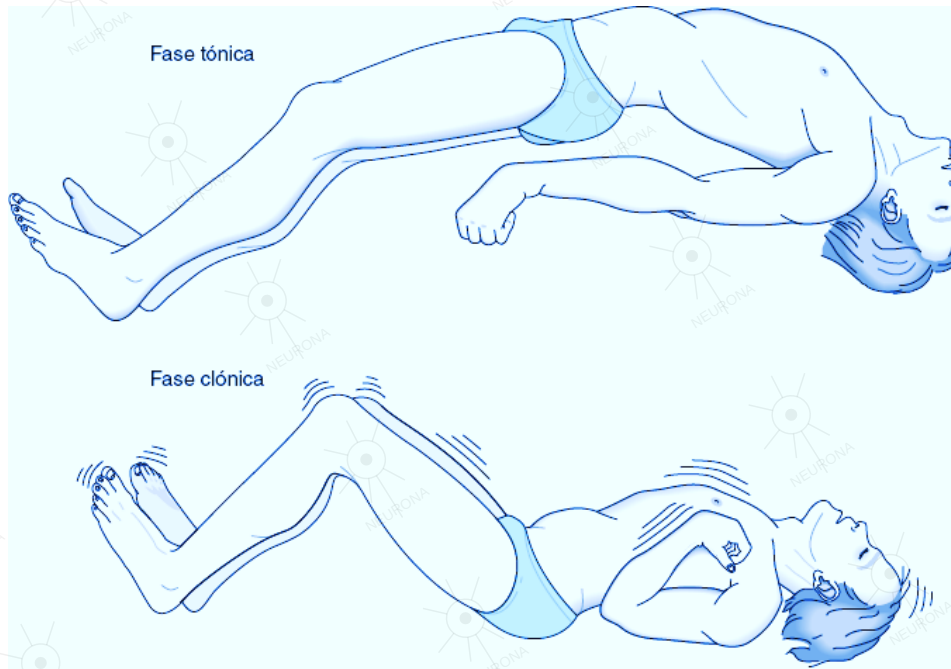
Inhidores DA

Bupropión, nomifensina, amineptino, manzidol
(intentan reducir el craving o apetencia por la droga)

**Tratamiento sintomático y soporte → BZD (loracepam 1-2 mg/cada 2-4 h de ser necesario, (m)8mg/24h*

Droga	Vía adm.	Efecto corto plazo	Efecto largo plazo	Acción
Opiáceos (heroína, morfina)	Oral, I.V, esnifada, fumada	Relajación, analgesia, disminución de miedo, ansiedad	Falta de deseo sexual, pérdida de peso, falta de interés	Depresor
Alcohol	Oral	Relajación, aumento de confianza, desinhibición, disminución de atención	Hepatotoxicidad, páncreas, impotencia	Depresor
Cocaína	Fumada, esnifada, I.V e inhalada	Reducción de la fatiga, lucidez o viveza mental, excitación, taquicardia	Insomnio, paranoia, perforación del tabique nasal, trastornos mentales	Estimulante
Anfetaminas	Oral, I.V y esnifada	Aumento de la concentración, verborrea, pérdida de apetito, confianza	Adelgazamiento, insomnio, depresiones, psicosis, agresividad	Estimulante
Cannabis	Oral y fumada	Alteraciones de la percepción, euforia, desinhibición	Disminución del rendimiento, perdida de interés, trastornos sexuales, psicosis	Estimulante (perturbador)
Éxtasis	Oral	Hiperactividad, verborrea, euforia, deseo sexual, ansiedad	Perdida de apetito, depresión, psicosis, paranoias	Estimulante (perturbador)

Crisis epilépticas



Fase Tónica:

Contracción muscular
(rigidez)

Fase Clónica:

Movimientos musculares
bruscos e involuntarios

Fase Post Convulsiva:

Agotamiento

Primeros auxilios

(Crisis epiléptica)

